TESTDOKUMENT · Inte publicerat eller granskat av PM:ets författare · Sammanfattningen är gjord av Kjell Stefansson, inte av författarna

MENINGIT OCH ENCEFALIT

Misstänkt ABM eller HSE • LP • Empirisk behandling

Gör allt parallellt – blanda till exempel läkemedlen medan LP förbereds. Överväg ABM och HSE hos alla patienter med akut neurologisk påverkan. Källa s. 1

01 DIREKT

Källa s. 2

- Uppmärksamma **vitalparametrar och livshotande organsvikt**. Notera **medvetandegrad** och **nackstyvhet**.
- **Blododlingar och blodprover** (se 04).
- Syrgas · iv-infart · **Ringer-acetat iv**.

- NPH-, svalg- och urinodling – **får EJ fördröja behandling**.
- Utred och behandla allvarliga differentialdiagnoser.
- **Överväg tidig intensivvårdskontakt.**

02 LÄKEMEDEL IV

Källa s. 2

ABM möjlig – först	**Betametason 0,12 mg/kg, max 8 mg.** Kan ges före LP.
ABM möjlig – antibiotika	**Cefotaxim 3 g + ampicillin (Doktacillin) 3 g.** När: se 03.
HSE möjlig	**Aciklovir 10 mg/kg.**
Misstanke om resistenta gramnegativa bakterier, eller immunsupprimerad patient	I stället för cefotaxim + ampicillin: **meropenem 2 g**.
Allvarlig allergi mot ordinarie betalaktamantibiotika	I stället: **moxifloxacin 400 mg** tillsammans med antingen **vankomycin 2 g** eller **linezolid 600 mg**.

03 LP – KONTRAINDIKATIONER OCH NÄR ANTIBIOTIKA GES

Källa s. 2

ABSOLUTA

- **Tecken på pågående cerebral inklämning:** t.ex. djup medvetslöshet (RLS 7–8), ljusstela pupiller, stigande blodtryck med bradykardi och/eller oregelbunden andning.
- **Tecken på fokal intrakraniell process** (som hjärnabscess): CNS-symtom >4 dygn, eller kort duration och tydliga motoriska bortfallssymtom (hemipares).
- **Infektion på planerat stickställe.**

RELATIVA

- **Koagulations-/blödningsrubbning:** PK >1,6 · TPK <30 × 10^9/l · känd blödningsbenägenhet · septisk chock och uppenbar koagulopati.
- **Warfarin, DOAK eller hög dos lågmolekylärt heparin.**
- Pågående kramper av epileptisk natur.
- Misstänkt ryggmärgskompression.
- Snabbt sjunkande medvetandegrad (RLS ≥4) eller kraftig psykomotorisk oro (stegrat intrakraniellt tryck).

ANTIBIOTIKA – NÄR?

Ingen kontraindikation →	**Gör LP** – mät lumbalt likvortryck, rör: se 04. Antibiotika **inom 30 min när 1 rör CSV tagits**.
Kontraindikation för LP eller tekniska svårigheter →	Antibiotika **direkt efter blododlingarna**.

04 PROVER

Källa s. 1

BLOD

- **Blododlingar:** 2 aeroba + 2 anaeroba.
- **Blodgas** (i första hand artärblod).
- Blodstatus, natrium, kalium, kreatinin, ALP, ALAT, albumin, bilirubin, PK, APT-tid, glukos.
- **Serum:** TBE-misstanke → S-TBE IgG+IgM, annars S-lagring.

CSV – 3–4 STERILA PLASTRÖR, MÄRKTA I NUMMERORDNING

Rör 1 · 2 ml	Csv-allmän odling, Csv-direktmikroskopi bakterier
Rör 2 · 1,5 ml	Csv-meningoencefalitblock (PCR)
Rör 3 · 1,5 ml	Csv-celler klassificering*, Csv-albumin*, Csv-glukos*
Ev. överblivet rör	Csv-lagring (bakt + virus)
+ 1 rör grå propp · 0,5–1 ml	Csv-laktat* (natriumfluorid/kaliumoxalat)
Jourtid	≥0,5 ml CSV i Pedibact- (eller aerob) blododlingsflaska, för Csv-allmän odling
*	Invänta dessa svar innan övriga analyser skickas.

Region Uppsala: "Meningit och encefalit - initial handläggning vid misstanke om allvarlig CNS-infektion".
DocPlusSTYR-14040 · version 6 · godkänt 2023-08-22.
Via akutkompassen.se/#pm=20808 · hämtat 2026-10-15.
Original-PM (DocPlus)

OM SAMMANFATTNINGEN

Detta är en sammanfattning av det angivna källdokumentet, genererad av Kjell Stefansson, ST-läkare i akutsjukvård, med hjälp av AI. Sammanfattningen ersätter inte originaldokumentet. Kontrollera aktuell version och lokal tillämplighet.

TESTDOKUMENT · Sammanfattning av Kjell Stefansson, inte av PM:ets författare